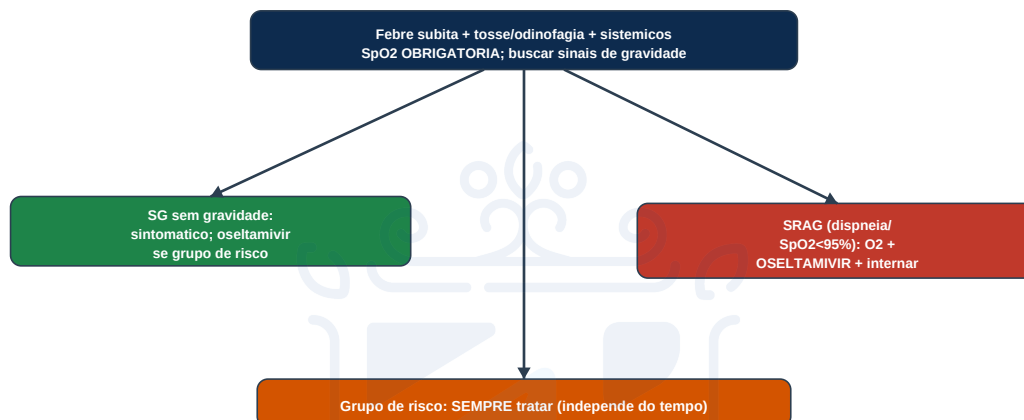


SÍNDROME GRIPAL — SRAG + OSELTAMIVIR

FLUXOGRAMA — SG x SRAG

GRIFE — CLASSIFICAR E TRATAR GRUPO DE RISCO



DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

RECONHECER A SÍNDROME

- SÍNDROME GRIPAL (SG): febre de início SÚBITO + tosse ou odinofagia + ≥ 1 sintoma sistêmico (cefaleia, mialgia, artralgia), SEM sinais de gravidade — maioria dos casos
- Influenza: início súbito (diferente do resfriado, gradual), febre alta (> 39), calafrios, mialgia intensa, tosse seca, prostração; tosse/fadiga podem durar semanas
- SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave): SG + dispneia OU SpO2 $< 95\%$ OU desconforto respiratório OU piora nas últimas 24h -> REQUER INTERNAÇÃO
- Complicações: pneumonia viral primária, pneumonia bacteriana secundária, descompensação de doença crônica, miocardite/encefalite (raras)
- Diferencial: resfriado comum/rinofaringite (coriza predominante, febre baixa/ausente)

GRUPOS DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES

SEMPRE TRATAR

- Gestantes (qualquer IG) e puérperas (até 2 semanas pós-parto)
- Crianças < 2 anos (especialmente < 6 meses) e idosos ≥ 60 anos
- Imunossuprimidos (HIV, quimioterapia, transplantados, corticoide > 20 mg/dia por > 14 dias)
- Doenças crônicas: pneumopatias (asma/DPOC), cardiopatias, DRC, diabetes, hematológicas (falciforme)
- Obesidade grave (IMC ≥ 40), indígenas aldeados, institucionalizados

SINAIS DE ALERTA (SRAG)

RED FLAGS

- Dispneia/desconforto respiratório; SpO2 $< 95\%$ em ar ambiente; cianose
- Taquipneia: adultos FR > 30 ; criança 2-12m FR > 50 ; 1-5 anos FR > 40 (< 2 meses FR > 60)
- Hipotensão (PAS < 90), alteração do nível de consciência, desidratação/recusa alimentar
- Tiragem intercostal/batimento de asa nasal; piora de doença crônica de base
- Complicação bacteriana: dor pleurítica, escarro purulento/hemoptoico, retorno da febre após 3-4 dias

DIAGNÓSTICO

CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO

- Durante a circulação do vírus (outono/inverno), o diagnóstico é CLÍNICO — quadro compatível + período epidêmico = influenza até prova em contrário
- NÃO é necessário teste para iniciar o tratamento em paciente de risco
- RT-PCR (swab nasofaríngeo): pacientes que internarão (SRAG), surtos em instituições, gestantes/puérperas, casos graves/atípicos
- Complementares (se SRAG/complicação): hemograma, PCR/procalcitonina, função renal, gasometria, RX de tórax, lactato se sepse
- Teste rápido de antígeno (influenza/COVID): útil para isolamento e notificação

TRATAMENTO — OSELTAMIVIR E SINTOMÁTICOS

Rx ANTIVIRAL POR INDICAÇÃO

TRATAR SEMPRE (independente do tempo de sintomas): todos os SRAG, todos os grupos de risco, gestantes/puérperas, < 2 anos, >= 60 anos, doenças crônicas, imunossuprimidos, obesidade grave, indígenas

OSELTAMIVIR adultos: 75 mg VO 12/12h por 5 dias; crianças por peso (< 15 kg 30 mg; 15-23 kg 45 mg; 23-40 kg 60 mg; > 40 kg 75 mg, 12/12h)

Ajuste renal: ClCr 30-60 -> 30 mg 12/12h; ClCr 10-30 -> 30 mg/dia; ClCr < 10 -> 30 mg dose única

Iniciar idealmente nas primeiras 48h, mas NÃO contraindicar após 48h em paciente de risco/grave; seguro em gestantes

Sintomáticos: Dipirona/Paracetamol (máx 4 g/dia); hidratação 2-3 L/dia; lavagem nasal com SF; EVITAR supressores da tosse (codeína)

ATB só em complicação bacteriana: Amox-clavulanato 500/125 8/8h por 7 dias (ou Ceftriaxona + Clindamicina se internar)

INTERNAÇÃO, ALTA E ORIENTAÇÕES

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: SRAG, SpO2 < 95% persistente, desconforto respiratório, desidratação/intolerância oral, alteração de consciência, pneumonia, gestante com gravidade, lactente < 3 meses com febre, paciente de risco descompensado
- ☐ ALTA: afebril 24-48h sem antitérmico, SpO2 >= 95%, sem desconforto, tolerando VO, baixo risco (ou de risco mas estável com oseltamivir), retorno garantido
- ☐ Casa: repouso 3-5 dias, hidratação, lavagem nasal, ISOLAMENTO respiratório (até 24h sem febre/7 dias), etiqueta respiratória, ambientes ventilados
- ☐ Alarme (retorno imediato): falta de ar, dor no peito, cianose, confusão/sonolência, febre > 3 dias ou que retorna, piora após melhora, vômitos persistentes; criança: irritabilidade/recusa/gemência
- ☐ Retorno em 3-5 dias se não melhorar; gestantes com obstetra

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com síndrome gripal evoluindo para SRAG; febre há ____ dias + tosse/mialgia; dispneia há ____, SpO2 ____% (ar ambiente), FR ____.
- Grupo de risco: ____; oseltamivir ____ (dose/há quanto tempo); O2 ____ L/min; ausculta ____.
- Exames: RX de tórax ____, hemograma ____, RT-PCR ____.
- Solicito transferência para enfermaria/UTI para suporte ventilatório e monitorização de SRAG por influenza.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

O que caracteriza a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e indica internação?

- A) Febre baixa isolada
- B) Síndrome gripal + dispneia OU SpO₂ < 95% OU desconforto respiratório OU piora nas últimas 24h
- C) Coriza predominante
- D) Apenas mialgia
- E) Tosse seca de 2 dias

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o antiviral de escolha para influenza e quando tratar pacientes de grupo de risco?

- A) Aciclovir, só nas primeiras 24h
- B) Oseltamivir, sempre (independente do tempo de sintomas) nos grupos de risco e na SRAG
- C) Azitromicina de rotina
- D) Tenofovir
- E) Nenhum antiviral

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre o diagnóstico de influenza em período epidêmico, é correto:

- A) Exige RT-PCR antes de qualquer tratamento
- B) É clínico-epidemiológico; não é necessário teste para iniciar o tratamento em paciente de risco
- C) Só pode ser feito com cultura viral
- D) Depende de hemocultura
- E) Requer biópsia

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual grupo deve receber oseltamivir mesmo se vacinado e mesmo após 48h de sintomas?

- A) Adultos jovens hígidos
- B) Gestantes, idosos, imunossuprimidos e demais grupos de risco / casos de SRAG
- C) Apenas crianças > 12 anos
- D) Somente pacientes afebris
- E) Ninguém

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Quando indicar antibiótico na influenza?

- A) Sempre, de rotina
- B) Apenas se complicação bacteriana (pneumonia secundária, retorno da febre após 3-4 dias, escarro purulento)
- C) Em todo paciente febril
- D) Apenas em crianças
- E) Nunca

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A SRAG é a síndrome gripal acompanhada de dispneia, $\text{SpO}_2 < 95\%$, desconforto respiratório ou piora nas últimas 24h — indicação de internação e suporte.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O oseltamivir é o antiviral de escolha; nos grupos de risco e na SRAG deve ser administrado SEMPRE, independentemente do tempo de sintomas (idealmente $< 48\text{h}$, mas não contraindicado depois).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Em período epidêmico, o diagnóstico é clínico-epidemiológico; não é preciso teste para iniciar o tratamento em paciente de risco. O RT-PCR fica para SRAG, surtos, gestantes e casos graves/atípicos.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Gestantes, idosos, imunossuprimidos e demais grupos de risco (e os casos de SRAG) devem receber oseltamivir mesmo vacinados e mesmo após 48h.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O antibiótico só é indicado na complicação bacteriana (pneumonia secundária, retorno/persistência da febre após 3-4 dias, escarro purulento), não de rotina na influenza.

SM24
Suporte ao Plantão Médico